Praxis für Pathologie am MVZ des Städtischen Klinikum Dresden
01067 Dresden

19. Oktober 2016

Screeningeinheit 3
Radiologische Gemeinschaftspraxis DD-BW
Loschwitzer Str.

Eingangsnummer: A_16_7591

Eingang: 17. Oktober 2016, 13:34

Patientin:
Frau M. K.
geboren am: 14. Mai 1956
VK-Nr.: 54321

Material:
HG-Stanzen/Mamma, li., 5 Uhr, 5 cm von Mamille/
US-gestützte Stanzbiopsie

Klinische Angaben
Untersuchungsanlass:
Herdbefund/Architekturstörung linke Brust
Symptome/Befunde:
BIRADS 4b

Pathologisch-anatomische Begutachtung

Makroskopische Beurteilung
Zwei, zusammen 22 mm lange, mittelfeste, grauweißliche Punktionszylinder von max. Bleistiftminenstärke. o.R.

Mikroskopische Beurteilung
In beiden vollständig gebetteten, mit jeweils vier Schnittstufen aufgearbeiteten Punktionszylindern lipomatös und fibrolipomatös transformiertes Brustdrüsengewebe, das zu großen Teilen eingenommen wird von Tumorstrukturen eines mittelgroßzelligen, vordergründig trabekulär, solid und dissolut einzelzellig wachsenden invasiven Mammakarzinoms mit mäßiger Zell- und Kernpolymorphie sowie ganz vereinzelt nachweisbaren Mitosen (weniger als 5/10 HPF). Im Tumorzentrum unerschiedlich ausgeprägte Stromasklerose und herdförmige -elastose. An der Tumorperipherie schüttere bis mitteldichte rundzellig entzündliche Stromareaktion.

Diagnose

Invsives Mammakarzinom, NST (Malignitätsgrad 2 nach Elston und Ellis: 3+2+1)

Tumorbox (Angaben gemäß Basisdatensatz ADT/GEKID und S3-Leitlinie 2018)
ICD-10 C50.5
Topographie ICD-O-3 C50.5
Morphologie ICD-O-3 M8500/32
ICD-O Version ICD-O-3; 2. Auflage 2013
Grading G2
Elston-Ellis-Summenscore 6 (3+2+1)

Klassifikation nach NHSBSP B5b
Östrogenrezeptor positiv (85% positive Tumorzellkerne)
Progesteronrezeptor positiv (50% positive Tumorzellkerne)
Her2neu negativ (nicht ampifiziert)
ki67-Index 10%
Materialart Stanzbiopsie
Anzahl der Stanzzylinder 2
Gesamtlänge der Stanzzylinder 2,2cm
Anzahl der Blöcke 1
Präparateradiogramm Präparateradiogramm gesehen
relevante MIkroverkalkungen nein
Korrelation Mikroverkalkung vorliegende Verkalkung radiologisch nicht relevant (kleiner 100µm)

Dr.med. J. Schö.
Oberärztin

19. Oktober 2016

Materialbearbeitung

Proben-ID	Proben-Art/Elternprobe	Prozedur
A7591_16	2 HG-Stanzzylinder 5 Uhr	Probeneingang
A7591_16_A_1	1 Paraffinblock/A7591_16	Einbetten
A7591_16_A_1_1_HE	4 Schnitte/block_A_1	HE-Färbung
A7591_16_A_1_1_ER	2 Schnitte/block_A_1	ER-IHC
A7591_16_A_1_1_PR	2 Schnitte/block_A_1	PR_-IHC
A7591_16_slide_A_1_1_HER2	2 Schnitte/block_A_1	HER2-B-DISH
A7591_16_A_1_1_ki67	2 Schnitte/block_A_1	ki67-IHC